



โรงพยาบาลเจาะไอร้อง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

หน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูง (ALS)

การนำเสนอผลการดำเนินงาน เพื่อขอรับการประเมินรับรองคุณภาพ TEMSA ชั้นที่ 1

📍 โรงพยาบาลเจาะไอร้อง • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

Thailand Emergency Medical Service Accreditation (TEMSA) • ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

📅 วันตรวจประเมิน: 30 มกราคม 2568 | วัฒนธรรมองค์กร FAST CIR & Non-Punitive Culture

🏆 ระดับการประเมิน

TEMSA ชั้นที่ 1

🕒 ขีดความสามารถ

ALS 24 ชั่วโมง

📋 ครอบคลุมเกณฑ์

6 องค์ประกอบ

🛡️ มาตรฐานความปลอดภัย

3P Safety Mesh

สารบัญการนำเสนอตามเกณฑ์มาตรฐาน TEMSA

6 องค์ประกอบหลัก

01

5 Core Criteria

การนำองค์กรและทิศทางเชิงกลยุทธ์

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม FAST CIR โครงสร้างสั่งการ และตัวชี้วัดสำคัญ

สไลด์ 08 - 12



02

4 Core Criteria

ระบบปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน

SOP 5 ช่วงปฏิบัติการ Response Time แผนอุบัติภัยหมู่ MCI และ Sky Doctor

สไลด์ 13 - 16



03

2 Core Criteria

การดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรค

CPG 5 กลุ่มโรค Fast Track: STEMI, Stroke, OHCA, Sepsis, Trauma & Obstetric

สไลด์ 17 - 20



04

2 Core Criteria

มาตรการความปลอดภัย

3P Safety (Patient, Provider, Public) บทบาท Safety Officer และ Near-Miss

สไลด์ 21 - 23



05

4 Core Criteria

การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ

ePCR NDEMS Audit 97.1% Master List 36 ฉบับ และการคุ้มครองข้อมูล PDPA

สไลด์ 24 - 26



06

4 Core Criteria

การบริหารทรัพยากรบุคคล

การกำกับใบอนุญาต 100% การฝึกอบรม สุขภาวะทีมกู้ชีพ และ Roadmap สู่ขั้นที่ 2

สไลด์ 27 - 30



ความพร้อมรับการประเมิน: เอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ครบถ้วน 217 รายการ พร้อมผลลัพธ์การดำเนินงาน 3 ปี

TEMSA Step 1 Audit



แหล่งอ้างอิง: เกณฑ์มาตรฐาน TEMSA 6 องค์ประกอบหลัก สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) พ.ศ. 2562

TEMSA Level 1 - ALS 01-2-905



👤 ข้อมูลทั่วไป & ศักยภาพหน่วยงาน

ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาลเจาะไอร้อง & ทรัพยากรกู้ชีพ

ข้อมูล ณ มิถุนายน 2568

ประชากรรับผิดชอบ

41,848 คน

3 ตำบล 44 หมู่บ้าน (sw.สต. 5 แห่ง)

ขีดความสามารถโรงพยาบาล

swช. 30 เตียง

ทีมกู้ชีพ ALS พร้อมปฏิบัติการ 24 ชม.

พาหนะฉุกเฉิน (Ambulance)

4 คัน (ALS 2 / BLS 2)

ประกันชั้น 1 คุ้มครอง 2 ล้าน/คน

อัตรากำลังบุคลากร EMS

45 คน

พยาบาล/ENP/Paramedic 39 คน
EMR 1 คน พวส 5 คน

🛡️ ความพร้อมปฏิบัติการ 24 ชม.: มีทีม ALS หมุนเวียนเวร 3 ผลัด พร้อมแพทย์อำนวยการ (Medical Director) ให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง

มาตรฐาน ALS Level

บริบทพื้นที่อำเภอเจาะไอร้อง & ผังเครือข่ายเชื่อมโยง

อำเภอเจาะไอร้อง จ.นราธิวาส

เครือข่ายปฐมภูมิ



รพ.สต. 5 แห่งในพื้นที่

- รพ.สต. ไอสะเตีย • รพ.สต. ปูกิต
- รพ.สต. มะรือโบออก • รพ.สต. ปีนามูดอ • รพ.สต. ปิเหล็ง

🏠 ส่งต่อเคสปฐมภูมิ & ประสานงานชุมชน

เครือข่ายกู้ชีพ อปท.



ชุดกู้ชีพ อบต. 3 แห่ง (BLS)

- อบต. จาบ • อบต. ปูกิต • อบต. มะรือโบออก

📄 บูรณาการ MOU & ร่วมออกเหตุเคสสีเขียว/เหลือง

หน่วยปฏิบัติการระดับสูง (ALS)

โรงพยาบาลเจาะไอร้อง หน่วยปฏิบัติการระดับสูง (ALS) 24 ชม.

- ✓ ออกเหตุวิกฤตสีแดง (Critical Red) ทันที
- ✓ Medical Direction ปรีกษาแพทย์ 24 ชม.
- ✓ Ambulance 4 คัน (ALS 2 / BLS 2)
- ✓ จุดเชื่อมโยงระบบสื่อสาร ePCR & 1669

📞 ศูนย์กลางประสานงานบัญชาการเหตุการณ์

รพ.แม่ข่ายส่งต่อตติยภูมิ



รพ.นราธิวาสราชนครินทร์

- ระยะทาง 32 กม. (ใช้เวลาเดินทาง 35-40 นาที)
- STEMI PCI / Stroke Thrombolytic / Trauma Center

➡ ระบบ Pre-notification ส่งต่อไร้รอยต่อ

ฝ่ายความมั่นคง & 1669



Scene Safety & ศูนย์สั่งการ

- ประสานความมั่นคงประเมินความปลอดภัยก่อนเข้าจุดเกิดเหตุ
- Sky Doctor รองรับการส่งต่อทางอากาศกรณีฉุกเฉิน

🛡️ ความปลอดภัย 3P Safety และความมั่นคง

สถิติการออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน (ปีงบประมาณ 2568)

ออกเหตุสะสม 562 ครั้ง/ปี | แจ้ง 1669 ครอบคลุม 100%



สรุปผลการวิเคราะห์ 3P (Purpose - Process - Performance)

6 หมวดมาตรฐาน TEMSA

องค์ประกอบเกณฑ์มาตรฐาน TEMSA	PURPOSE (นโยบาย)	PROCESS (SOP/แนวทาง)	PERFORMANCE (ผลลัพธ์)	สถานะประเมิน & ข้อสรุป
1 อ.1 การบริหารจัดการองค์กร	✔ ครบถ้วน	✔ ครบถ้วน	⦿ บางส่วน	ผ่านเกณฑ์ดี FAST CIR ชัดเจน · พัฒนาต่อต้าน KPIs Stroke
2 อ.2 มาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉิน	✔ ครบถ้วน	⦿ บางส่วน	⦿ บางส่วน	พัฒนาต่อเนื่อง มี SOP 5 ระยะ / MCI · พัฒนาเวลาส่งต่อ Stroke
3 อ.3 การดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรค	✔ ครบถ้วน	✔ ครบถ้วน	⦿ บางส่วน	ผ่านเกณฑ์ดี CPG 5 Fast Track ครบ · STEMI 100% · ยกระดับ ROSC
4 อ.4 มาตรการความปลอดภัย	✔ ครบถ้วน	⦿ บางส่วน	⦿ บางส่วน	พัฒนาต่อเนื่อง 3P Safety ครบ 100% · ไม่มีอุบัติเหตฺ · พัฒนา Digital Near-Miss
5 อ.5 การจัดการข้อมูลสารสนเทศ	✔ ครบถ้วน	✔ ครบถ้วน	✔ ครบถ้วน	ผ่านสมบูรณ์ Master List 36 รายการ · PDPA 100% · ePCR Audit 97.1%
6 อ.6 การบริหารทรัพยากรบุคคล	✔ ครบถ้วน	✔ ครบถ้วน	✔ ครบถ้วน	ผ่านสมบูรณ์ ใบอนุญาต 100% · TNA/IDP ครบถ้วน · สุขภาพจิต ST5/9Q ดีเยี่ยม

สรุปเพิ่มเอกสารหลักฐานทั้ง 6 องค์ประกอบ (รวม ≈ 217 เพิ่ม)

✔ พร้อมรับการสุ่มตรวจ 100%

1 การบริหารจัดการองค์กร

≈ 122 เพิ่ม

- ▶ คำสั่งแต่งตั้ง คกก. 11 ท่าน (151/2569) & แผนผังสายบังคับบัญชา
- ▶ วิสัยทัศน์ พันธกิจ, ค่านิยม FAST CIR & แผนยุทธศาสตร์ Road Map
- ▶ รายงาน KPI Dashboard 5 ด้าน & ทะเบียนบริหารความเสี่ยง Risk Register

👤 นพ.อิลมีย์ (Medical Dir.)

5 หมวดหลัก

2 มาตรฐานการปฏิบัติงาน

30 เพิ่ม

- ▶ คู่มือขั้นตอนปฏิบัติการ SOP 5 ระยะ (Pre-shift ถึง Reset)
- ▶ แผนอุบัติเหตุหมู่ (MCI Plan) + บันทึกการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุภาคสนาม
- ▶ เกณฑ์ลำเลียง Sky Doctor, MOU เครือข่าย 4 ฉบับ & บันทึกระบบ AAR

🚑 Activation ≤ 2 นาที

ITEMS Ready

3 การดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรค

8 เพิ่ม

- ▶ 5 Fast Track CPGs: STEMI (D2N 100%), Stroke, Trauma, TBI, OHCA
- ▶ 3 Case Mix ชุมชน: Sepsis (Abx 1 ชม. 100%), COPD, คลอดฉุกเฉิน
- ▶ Standing Orders, Online Direction Protocol & Smart App คำนำวน GA

💓 EKG 12-Lead 10 นาที

Cath Lab ยะลา

4 มาตรการความปลอดภัย

16 เพิ่ม

- ▶ นโยบาย 3P Safety (Patient, Provider, Public) & คำสั่ง Safety Officer
- ▶ บันทึกตรวจ PPE, ควบคุมความเร็ว GPS ≤ 90 กม./ชม. & กรมธรรม์รถ 4 คัน
- ▶ รายงาน Near-Miss 26 เหตุการณ์, ผลวิเคราะห์ RCA & Just Culture Policy

🛑 Zero Ambulance Accident

วิทยุ ว. ช่อง 9/10

5 การจัดการข้อมูลสารสนเทศ

22 เพิ่ม

- ▶ Master List ควบคุมเอกสาร 36 รายการ (POL, MAN, SOP, CPG, FM)
- ▶ นโยบาย PDPA, หนังสือยินยอมรักษาความลับ (บุคลากรผ่านอบรม 45 คน 100%)
- ▶ ทะเบียนผล Audit ePCR / NDEMS (ความสมบูรณ์ 96.0-97.1%) & ระบบ Backup

🔒 Role-based Access

Google Drive Cloud

6 การบริหารทรัพยากรบุคคล

19 เพิ่ม

- ▶ แผนฝึกอบรม TNA 3 อันดับแรก & แผนพัฒนารายบุคคล IDP ครบ 100%
- ▶ ระบบแจ้งเตือนต่ออายุใบอนุญาต 90/60/30 วัน (อัตราหลุดต่ออายุ = 0%)
- ▶ ผลคัดกรองสุขภาพจิต ST5/9Q (เครียดน้อย 93.3%) & ตรวจสอบสุขภาพกาย 100%

👥 กำลังคน 45 นาย

On-Call 24 ชม.

📁 การจัดเก็บเอกสาร: จัดหมวดหมู่ใน Google Drive ควบคุมความปลอดภัย ควบคุมเพิ่ม Hardcopy ประจำห้อง EMS พร้อมเปิดตรวจได้ทันที

✔ ทบทวนรายปี ✔ QR-Code Ready

องค์ประกอบที่ 1

การบริหารจัดการองค์กร (Organization Management)

แสดงถึงทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ โครงสร้างการบังคับบัญชา ค่านิยมองค์กร ระบบบริหารความเสี่ยง และแผนการพัฒนาคูณภาพของโรงพยาบาล

✓ 3 เกณฑ์คุณภาพ 13 ข้อกำหนด 8 Core Criteria

แหล่งอ้างอิง: เกณฑ์ TEMSA องค์ประกอบที่ 1: การบริหารจัดการองค์กร (Organization Management Standards)

TEMSA Level 1 - ALS 01-2-905

< ย้อนกลับ

ถัดไป >

เลือกสไลด์:

08. [หมวด] องค์ประกอบที่ 1



วิสัยทัศน์ พันธกิจ & ค่านิยมองค์กร

วิสัยทัศน์ (VISION)

2568 - 2571

"หน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ประชาชนเข้าถึง
ง่ายอย่างเท่าเทียม ภาครัฐช่วยร่วมใจเพื่อความปลอดภัยของชีวิต"

ทิศทางมุ่งสู่ TEMSA ชั้นที่ 1

เป้าหมาย 100%

พันธกิจหลัก 4 ด้าน (MISSION PILLARS)

4 ยุทธศาสตร์

1 พัฒนามาตรฐานการดูแล
ยกระดับกู้ชีพ ALS & ER ตลอด 24 ชม.

2 เสริมแกร่งภาคีเครือข่าย
บูรณาการ อบต. 3 แห่ง & รพ.สต. 5 แห่ง

3 ส่งต่อวิกฤตไร้รอยต่อ
Fast Track Stroke / STEMI / Trauma

4 ส่งเสริมความรู้ชุมชน
อบรม CPR & AED แก่ อสม. สม่่าเสมอ

ค่านิยมหลักองค์กร (CORE VALUES) – "FAST CIR"

วัฒนธรรมขับเคลื่อนความปลอดภัย 7 มิติ

F

First Response &
Flexibility

ตอบสนองไว ยืดหยุ่นได้

A

Accountability

รับผิดชอบ ตรวจสอบได้

S

Safety First

ความปลอดภัย 3P สูงสุด

T

Trust & Teamwork

สร้างเชื่อมั่น ทำงานเป็นทีม

C

Compassion

ใส่ใจเอื้ออาทรผู้บริการ

I

Innovation & CQI

พัฒนานวัตกรรมต่อเนื่อง

R

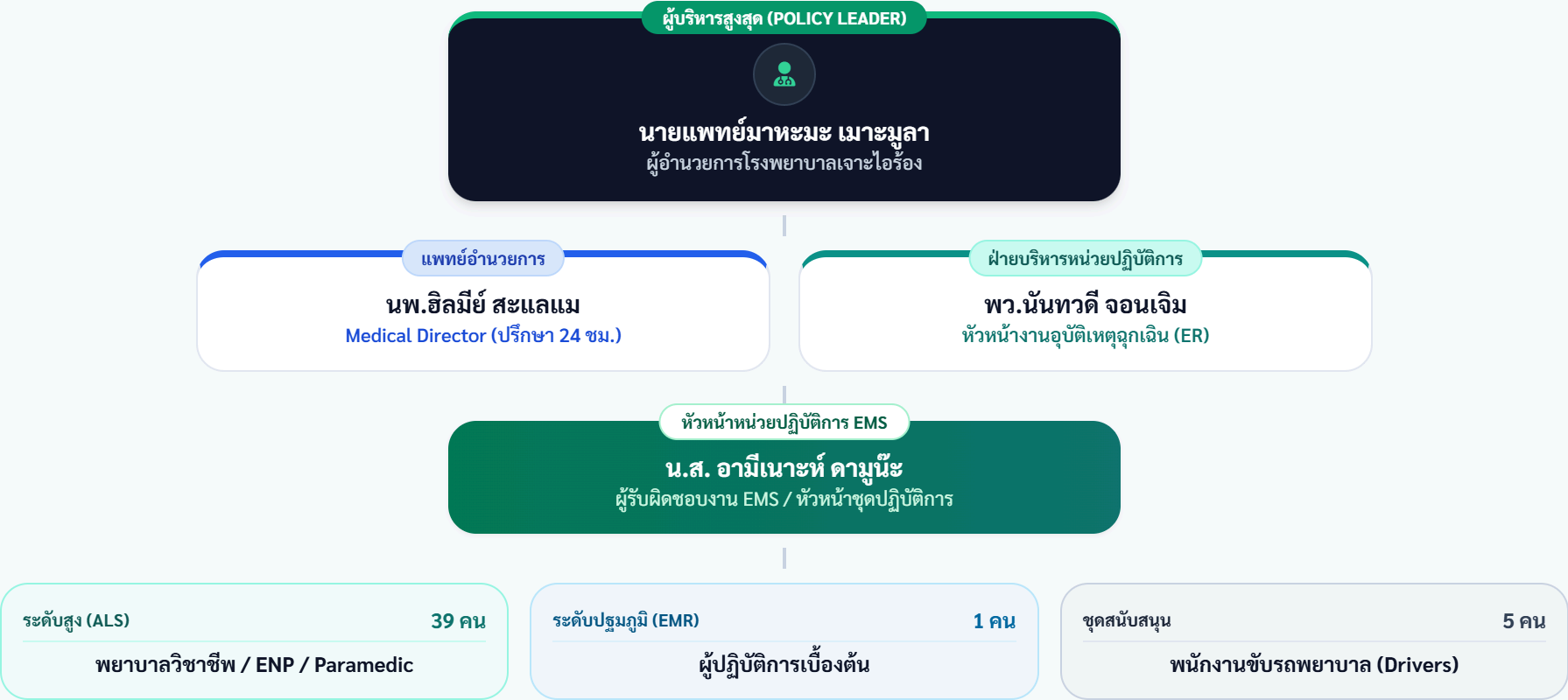
Respect

เคารพพหุวัฒนธรรม

องค์ประกอบที่ 1 (ฝั่งสายบังคับบัญชา)

แผนผังโครงสร้างการบริหารงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน & EMS

สายบังคับบัญชา & อัตรากำลัง 45 คน



แหล่งอ้างอิง: คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน & EMS รพ.เจ้าพระยา (ฉบับปี 2568)

TEMSA Level 1 - ALS 01-2-905

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดหลัก 5 ด้าน

สรุปผลงานปี 2568

ด้าน / ตัวชี้วัดคุณภาพ	เกณฑ์เป้าหมาย	ผลจริง (2568)	สถานะ
🕒 Response Time ≤ 8 นาที (ผู้ป่วยวิกฤตสีแดง)	≥ 80%	81.25%	✓ ผ่านเกณฑ์
🔔 Activation Time ≤ 2 นาที	≥ 95%	96.4%	✓ ผ่านเกณฑ์
🏥 Door-to-Needle Time (STEMI) ≤ 30 นาที	≥ 80%	100% (6/6 เคส)	✓ ยอดเยี่ยม
🏥 Stroke Fast Track ส่งต่อทันเวลา ≤ 30 นาที	≥ 80%	53.70% (29/54 เคส)	⬆ กำลังพัฒนา
😊 ความพึงพอใจผู้รับบริการ	≥ 85%	92.8%	✓ ผ่านเกณฑ์
🛑 จำนวนอุบัติเหตุที่เกิดระหว่างลำเลียงผู้ป่วย	0 ครั้ง	0 ครั้ง	✓ ปลอดภัย 100%

🔍 **แผนพัฒนาตัวชี้วัด (Action Plan สำหรับ Stroke Fast Track & อุปรณ)**

มุ่งเน้นการปรับปรุงระบบ Pre-notification, One page checklists ช่วยในการตัดสินใจส่งต่อ Stroke Fast Track ให้ได้ตามเป้าหมาย ≥ 80% และเข้มงวด Pre-shift Checklist ทุกผลัดเวรเพื่อรักษาสถิติความพร้อม 100%

📄 แหล่งอ้างอิง: รายงานตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก (KPI Dashboard 5 ด้าน) กลุ่มงานการพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉิน

TEMSA Level 1 · ALS 01-2-905

แผนผังและเส้นทางการพัฒนาสู่มาตรฐาน TEMSA

แผนการดำเนินงาน 4 ระยะ (พ.ศ. 2568 - 2571)



🚒 องค์ประกอบที่ 2

มาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉิน (Emergency Operations)

ครอบคลุมขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน (SOP) ตลอด 5 ระยะของการกู้ชีพ แผนอุบัติเหตุหมู่ (MCI) และระบบส่งต่อทางอากาศยาน (Sky Doctor)

✓ 3 เกณฑ์คุณภาพ 📋 10 ข้อกำหนด ★ 7 Core Criteria

📄 แหล่งอ้างอิง: เกณฑ์ TEMSA องค์ประกอบที่ 2: มาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉิน (Emergency Operations Standards)

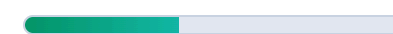
TEMSA Level 1 - ALS 01-2-905

< ย้อนกลับ

ถัดไป >

เลือกสไลด์:

13. [หมวด] องค์ประกอบที่ 2



มาตรฐานขั้นตอนปฏิบัติการฉุกเฉิน (SOP 5 Phases)

ครอบคลุมทุกวงจรการกู้ชีพ ALS

1

ระยะที่ 1

เตรียมพร้อมก่อนเวร

✓ Pre-shift Checklist ยา/เครื่องมือ 100%

✓ เช็ค Defibrillator, Suction, O2

✓ รายงานความพร้อมผ่าน NDEMS

→ พร้อมออกเหตุ 24 ชม.

2

ระยะที่ 2

ระหว่างเดินทาง

✓ Activation Time ≤ 2 นาที (96.4%)

✓ Response Time ≤ 8 นาที (81.25%)

✓ ขับขี่ปลอดภัย ≤ 90 กม./ชม. + GPS

→ สื่อสารศูนย์ 1669

3

ระยะที่ 3

ณ จุดเกิดเหตุ

✓ Scene Safety ประเมินความปลอดภัย

✓ Primary Survey: ABCDE Framework

✓ ALS Interventions / ปฐมพยาบาล

→ กู้ชีพขั้นสูงทันที

4

ระยะที่ 4

ระหว่างลำเลียง

✓ Monitor สัญญาณชีพทุก 5 นาที

✓ Spinal Precaution เคร่งครัด

✓ Pre-notification ส่งสัญญาณแจ้ง ER

→ เตรียมพร้อมรับผู้ป่วย

5

ระยะที่ 5

ส่งมอบ & บันทึก

✓ ส่งมอบด้วยเทคนิค ISBAR / MIST

✓ พยาบาล ER ลงนามรับมอบเป็นหลัก

✓ บันทึก ePCR / NDEMS ครบ 100%

→ รายงานอุบัติการณ์ & AAR

Checklist ความพร้อม, ระบบ AAR & สถิติ Response Time

PRE-SHIFT CHECKLIST

ทุกผลัดเวร



อัตรากำลัง 3 ผลัด 24 ชม.

พยาบาล 1, นฉพ./EMT 1, พชร. 1 พร้อมเวร On-Call ลายลักษณ์อักษร



ตรวจสอบสภาพรถ & อุปกรณ์กู้ชีพ

AED/Defib, ถัง O₂, ยา High Alert, DTX, ชุดคลอด, Long Spinal Board



รายงานสถานะระบบ ITEMS

บันทึกความพร้อมออนไลน์ส่งส่วนกลาง สพฉ. ทุกวันครบ 100%



พร้อมออกเหตุทันที

100% Ready



AFTER ACTION REVIEW (AAR)

ภายใน 24 ชม.



ทบทวนเคสวิกฤต/ซับซ้อน

เคส CPR, Fast Track, อุบัติภัยหมู่ ร่วมกับ Medical Director



กระบวนการ 4 คำถามหลัก

1. แผนที่วาง → 2. สิ่งที่เกิดขึ้นจริง → 3. ปัญหาที่พบ → 4. แนวทางแก้ไข



ผลลัพธ์เชื่อมสู่ CQI

ปรับปรุงแนวปฏิบัติ CPG, เต็มเวชภัณฑ์สำรอง และจัดอบรม TNA ทันที



วัฒนธรรม Just Culture

AAR Logbook



RESPONSE TIME TREND

ย้อนหลัง 3 ปี

ปี 2566: เฉลี่ย 8.2 นาที

78.0%

ปี 2567: เฉลี่ย 7.9 นาที

80.5%

ปี 2568: เฉลี่ย 7.5 นาที

82.50%

Activation ≤ 2 นาที: 96.00%

ผ่านเกณฑ์ ✓

GPS ≤ 90 กม./ชม.

อุบัติเหตุ 0 ครั้ง



มาตรฐานความพร้อมและการพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง: ตรวจสอบความพร้อมก่อนเริ่มเวร 100% → ตอบสนองรวดเร็ว (Activation 96%) → ปลอดภัยด้วย GPS → ทบทวน AAR ทุกเคสสำคัญ



SOP Standardized



แหล่งอ้างอิง: ระบบบันทึกความพร้อม ITEMS สพฉ. & ทะเบียนทบทวนเวชปฏิบัติ After Action Review (AAR Logbook)

TEMSA Level 1 - ALS 01-2-905

แผนรองรับอุบัติเหตุหมู่ (MCI) & ระบบลำเลียงทางอากาศ

บูรณาการร่วมภาคีเครือข่าย



แผนรองรับอุบัติเหตุหมู่ (MCI PLAN & ICS)

MOPH Triage



MOU เครือข่ายบูรณาการ 4 ฉบับ:

ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับ อบต. 3 แห่ง, รพ.สต. 5 แห่ง, ฝ่ายปกครอง และหน่วยความมั่นคง



ระบบสั่งการ METHANE + START Triage:

รายงานเหตุตามหลัก METHANE และคัดแยก 4 สี (แดง, เหลือง, เขียว, ดำ)



การฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ (TTX & Field):

ซ้อมแผนจำลองสถานการณ์อุบัติเหตุใหญ่และพื้นที่ความไม่สงบเป็นประจำทุกปี



รองรับผู้บาดเจ็บจำนวนมากด้วยระบบ Incident Command System (ICS)



ระบบส่งต่อทางอากาศยาน (SKY DOCTOR)

Fit to Fly



ขีดความสามารถการลำเลียงทางอากาศ:

ส่งต่อผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินในพื้นที่ทุรกันดาร จุดอับสัญญาณ และพื้นที่เสี่ยงความมั่นคง



Pre-flight Checklist & จุดจอดปลอดภัย:

ประสานศูนย์ 1669 นราธิวาส & Skydoctor และเตรียมฝึกจุดจอดร่วมกับทหารพราน/ตชด.



ส่งต่อศูนย์ตติยภูมิระดับสูง (Tertiary Care):

ประสานเครือข่าย รพ.สงขลานครินทร์ (มอ.) และ รพ.ศูนย์ยะลา ได้อย่างรวดเร็วไร้รอยต่อ



ยกระดับโอกาสรอดชีวิตในผู้ป่วยวิกฤตซับซ้อนตามมาตรฐานเขตสุขภาพที่ 12



ความพร้อมรับมืออุบัติเหตุทุกระดับ: มีเครือข่าย ICS รองรับบนภาคพื้นดิน และช่องทาง Sky Doctor ทางอากาศ เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของประชาชน



MCI & Aero Ready

องค์ประกอบที่ 3

การดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรค (Clinical Standards)

แนวทางเวชปฏิบัติ (CPG) สำหรับโรควิกฤตฉุกเฉิน 5 กลุ่มโรค Fast Track และแนวปฏิบัติเฉพาะ
บริบทพื้นที่โรงพยาบาลเจาะไอร้อง

✓ 1 เกณฑ์คุณภาพ ☰ 4 ข้อกำหนด ★ 2 Core Criteria

📄 แหล่งอ้างอิง: เกณฑ์ TEMSA องค์ประกอบที่ 3: การดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรค (Clinical Care Standards)

TEMSA Level 1 - ALS 01-2-905

การดูแลผู้ป่วยวิกฤตเฉพาะโรค (STEMI & Stroke Fast Track)

CPG 5 กลุ่มโรค Fast Track



STEMI FAST TRACK PROTOCOL

D2N ≤ 30 นาที



12-Lead EKG Rapid Diagnostic:

ทำ EKG 12 Leads ภายใน **10 นาที**



Immediate Antiplatelet:

ให้ยา Aspirin 300 mg (chewing stat) ทันทีตาม CPG ร่วมกับแพทย์อำนาจการ 24 ชม.



Door-to-Needle Time ≤ 30 นาที

100% Pass

*บรรลุเป้าหมาย 100% ครบทุกรายต่อเนื่อง (สะสมปี 2566 - 2568)



มาตรฐานสถาบันโรคหัวใจ

100% Success



STROKE FAST TRACK PROTOCOL

BEFAST Screening



BEFAST Assessment & DTX:

ประเมินอาการหลอดเลือดสมอง (BEFAST) ร่วมกับเจาะ DTX เพื่อตัดภาวะ Hypoglycemia



Pre-notification & Rapid Refer:

แจ้งศูนย์ส่งต่อ รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ เตรียม CT Brain & ให้ยา rtPA ล่วงหน้า



อัตราเข้าถึงบริการส่งต่อทันเวลา

53.70% (29/54)

*เป้าหมาย ≥ 80% (อยู่ระหว่างพัฒนา Action Plan ปรับปรุงเวลารอคอย)



CQI Continuous Improvement

Action Plan



สรุปความพร้อมการดูแล Fast Track: มี CPG & SOP ชัดเจน 100% พร้อมระบบ Pre-notification และ Medical Direction 24 ชั่วโมง

CPG Standardized

การดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรค (OHCA, Sepsis & Severe Trauma)

Clinical CPG Guidelines



1. OHCA CPG

หัวใจหยุดเต้นนอก รพ.

High-Quality CPR

✓ Continuous CPR: สึก 2-2.4 นิ้ว เร็ว 100-120 ครั้ง/นาที

✓ Early Defibrillation: ติด AED/Defib ภายใน 3 นาที + ยึดตาม CPG

อัตราการรอดชีวิต ROSC Rate

28.5%

*เป้าหมายพัฒนา ROSC Rate ร่วมกับเครื่องช่วย FR



2. Severe Sepsis

ติดเชื้อในกระแสเลือด

Hour-1 Bundle

✓ qSOFA Screening: คัดกรองเร็วด้วย qSOFA & Hemoculture

✓ IV Fluid + Antibiotic: โทลด์น้ำและฉีดยาฆ่าเชื้อใน 1 ชม.

ให้ Antibiotic ทันเวลาใน 1 ชม.

100%

*บรรลุเป้าหมาย 100% (16/16 ราย ในปี 2568)



3. Severe Trauma

บาดเจ็บรุนแรง & TBI

Rapid Refer

✓ Spinal Immobilization: ตรึงกระดูกสันหลัง 100% ทุกราย

✓ Bleeding Control: ห้ามเลือดเร็ว พร้อมลำเลียงส่งต่อ

ส่งต่อ Severe TBI ภายใน 1 ชม.

100%

*บรรลุเป้าหมาย 100% (10/10 ราย ในปี 2568)



การพัฒนาคุณภาพการบริการต่อเนื่อง (Clinical CQI): ปรับปรุงกระบวนการดูแล Severe TBI ส่งต่อ รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ ภายใน 1 ชม. ได้ 100% ครบทุกราย

✓ CPG Standardized

แหล่งอ้างอิง: AHA CPR & ECC Guidelines 2020, Surviving Sepsis Campaign 2021 & PHTLS 9th Edition

TEMSA Level 1 - ALS 01-2-905

แนวปฏิบัติ CPG: ภาวะหายใจเหนื่อยลำบาก & การคลอดฉุกเฉิน

Respiratory & Obstetric CPG

Respiratory Distress (เหนื่อยวิกฤต)

O2 Therapy & SpO2

- ✓ **Airway & Obstruction:** ประเมินทางเดินหายใจ ตรวจสอบภาวะอุดกั้น และสิ่งแปลกปลอม
- ✓ **O2 Therapy ตามกลุ่มโรค:** ดูแล SpO2 ในผู้ป่วย COPD ให้อยู่ในช่วง **88 - 92%**
- ✓ **ยาพ่น & Monitor ต่อเนื่อง:** พ่นยาขยายหลอดลมตาม CPG พร้อมวัดชีพจรและ SpO2 ตลอดทาง

🚑 รักษาความคงที่ของทางเดินหายใจตลอดการลำเลียง

การคลอดฉุกเฉิน (Obstetric Emergency)

Smart App & PPH Guard

- ✓ **Triage & ห้ามเคลื่อนย้าย:** ประเมินแรงเบ่ง หากศีรษะทารกโผล่ให้ทำคลอดฉุกเฉินทันที
- ✓ **ทำคลอด & ป้องกัน PPH:** ดูดเสมหะ เช็ดตัวให้อบอุ่น และนวดมดลูกป้องกันการตกเลือด
- ✓ **Smart App คำนำณ GA/EDC:** นวัตกรรมแอปพลิเคชันช่วยคำนวณอายุครรภ์และวันคลอดแม่นยำ

🛡️ ปกป้องทั้งมารดาและทารกตามมาตรฐาน CPG

💡 **นวัตกรรมสนับสนุนทีมงาน (Health Tech Integration):** Smart App ช่วยเพิ่มความแม่นยำในการตัดสินใจทางคลินิกแก่ทีม ALS

✓ 100% CPG Compliance

องค์ประกอบที่ 4

มาตรการความปลอดภัย (Safety & Security)

มาตรการความปลอดภัย 3P Safety (Patient, Provider, Public) ระบบบริหารความเสี่ยง การควบคุมเหตุการณ์เกือบพลาด (Near-Miss) และสิ่งแวดล้อมกายภาพ

2 เกณฑ์คุณภาพ 3 ข้อกำหนด 2 Core Criteria

แหล่งอ้างอิง: เกณฑ์ TEMSA องค์ประกอบที่ 4: มาตรการความปลอดภัยและระบบความเสี่ยง (Safety & Security Standards)

TEMSA Level 1 - ALS 01-2-905

องค์ประกอบที่ 4 (ฝั่งความปลอดภัย 3P Safety)

ผังบูรณาการความปลอดภัย 3P Safety Framework (Patient ↔ Provider ↔ Public)

ZERO ACCIDENT PROTOCOL

1. Patient Safety

ความปลอดภัยของผู้ป่วย

Safe Care

- ✓ ระบุตัวตน 2 ตัวชี้วัด: ชื่อ-สกุล & วันเดือนปีเกิด/HN ก่อนบริหารยาและทำหัตถการ
- ✓ ป้องกันพลัดตกเตียง: ล็อก Safety Belt บนเตียงพยาบาลและปลดัก 100%
- ✓ High Alert Drugs: Double Check ขนาดยาและข้อบ่งชี้ตาม CPG
- ✓ Scope of Practice: ปฏิบัติการตามกรอบวิชาชีพ พ.ร.บ.การแพทย์ฉุกเฉิน

มาตรฐานการดูแล

100% Compliance

2. Provider Safety

ความปลอดภัยของทีมงาน

Staff Welfare

- ✓ สวมใส่ PPE ตามเกณฑ์: N95, Goggles, Isolation Gown Level C ครอบคลุม
- ✓ Scene Safety First: พื้นที่ความมั่นคงรอสัญญาณ Clear Scene ก่อนเข้าพื้นที่
- ✓ สวัสดิการ & ประกันภัย: ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 200,000 บ. + เบี้ยเลี้ยงภัย
- ✓ วัคซีน & สุขภาพ: ได้รับวัคซีน HBV/Flu 100% พร้อมประเมินสุขภาพจิต

คุ้มครองทีมงาน

100% Insured

3. Public Safety

ความปลอดภัยของสาธารณะ

Zero Accident

- ✓ ควบคุมความเร็วด้วย GPS: จำกัดความเร็วรถกู้ชีพไม่เกิน 90 กม./ชม.
- ✓ Defensive Driving: พนักงานขับรถผ่านการอบรมขับขี่ปลอดภัยครบ 100%
- ✓ ประกันภัยรถพยาบาล: ทำประกันภัยชั้น 1 รถ Ambulance ทั้ง 4 คัน (2 ลบ./คน)
- ✓ สถิติอุบัติเหตุ: อุบัติเหตุระหว่างปฏิบัติการสะสม 0 ครั้ง ต่อเนื่อง

อุบัติเหตุรถพยาบาล

0 ครั้ง (100%)



วัฒนธรรมความปลอดภัยแบบองค์รวม (Integrated 3P Safety): ผสานความปลอดภัย 3 เสาหลักควบคู่ Just Culture สู่เป้าหมาย Zero Harm และ Zero Accident 100%

3P Enforced

แหล่งอ้างอิง: กรอบความปลอดภัย 3P Safety Framework (WHO Guidelines / 2P Safety สรพ.) & มาตรฐานรถกู้ชีพ สพฉ.

TEMSA Level 1 - ALS 01-2-905

< ย้อนกลับ

ถัดไป >

เลือกสไลด์:

22. อ.4 มาตรการความปลอดภัย 3P



Safety Officer & ระบบบริหารจัดการความเสี่ยง (Near-Miss)

Non-Punitive Culture

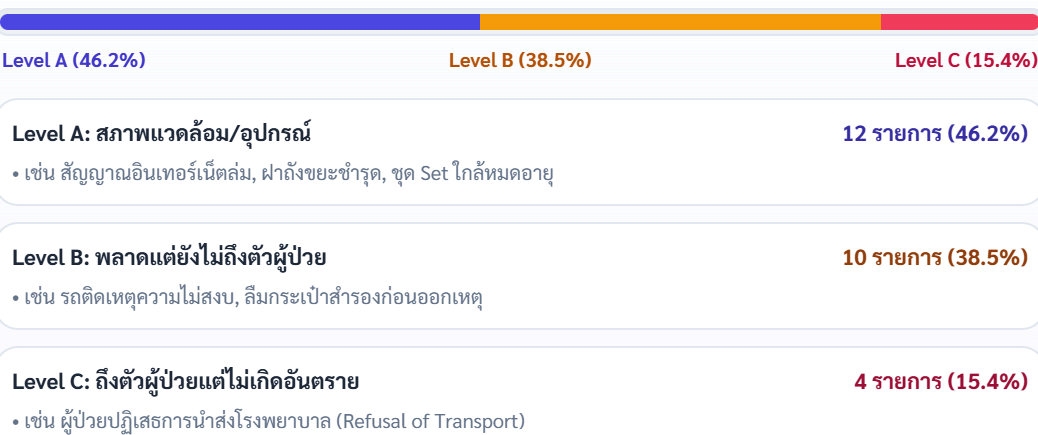
บทบาทหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (SAFETY OFFICER)

- ✓ **ขับเคลื่อน 3P Safety:** กำกับดูแลความปลอดภัยของผู้ป่วย ทีมกู้ชีพ และสาธารณชน
- ✓ **ตรวจสอบ ENV & รถพยาบาล:** ตรวจสอบสภาพสิ่งแวดล้อมกายภาพและความพร้อมรถกู้ชีพตาม Checklist
- ✓ **กำกับชุด PPE & เครื่องมือ:** ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ป้องกันและยาฉุกเฉินทุกผลัด
- ✓ **วิเคราะห์ความเสี่ยง RCA:** นำรายงาน Near-Miss เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้เชิงระบบ

🏡 วัฒนธรรมความปลอดภัยแบบไม่มุ่งเน้นการลงโทษ (Just Culture)

สรุปสถิติความเสี่ยง NEAR-MISS (26 เหตุการณ์)

รวม 26 รายการ



องค์ประกอบที่ 5

การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ (Information Management)

ระบบควบคุมเอกสาร Master List 36 รายการ การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และคุณภาพเวชระเบียนฉุกเฉิน (ePCR/NDEMS)

✓ 2 เกณฑ์คุณภาพ ☰ 4 ข้อกำหนด ★ 4 Core Criteria

📄 แหล่งอ้างอิง: เกณฑ์ TEMSA องค์ประกอบที่ 5: การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ (Information Management Standards)

TEMSA Level 1 - ALS 01-2-905



ผลประเมินความสำเร็จการลงข้อมูล ePCR & โครงการ CQI

ผลการประเมินความสำเร็จ 5 หมวดหลัก (EPCR NDEMS)

เป้าหมาย ≥ 95%

หมวดการประเมิน (Assessment Items)	ผลการประเมิน	เกณฑ์มาตรฐาน	สถานะ
1. ข้อมูลทั่วไปและประวัติผู้ป่วย	100.0%	≥ 95.0%	✓ ดีเยี่ยม
2. สัญญาณชีพและอาการสำคัญ (Vital Signs)	98.2%	≥ 95.0%	✓ ผ่านเกณฑ์
3. การประเมินแรกรับและระหว่างนำส่ง (ABCDE)	96.8%	≥ 95.0%	✓ ผ่านเกณฑ์
4. บันทึกระยะเวลาแต่ละขั้นตอน (Time Logs)	96.0%	≥ 95.0%	✓ ผ่านเกณฑ์
5. บันทึกยาและหัตถการเรียงลำดับเวลา Chronological Meds & Actions	94.5%	≥ 90.0%	✓ พัฒนาต่อ

ความสำเร็จเฉลี่ยรวมทุกหมวด

97.1% (เป้าหมาย ≥ 95%)



โครงการ CQI พัฒนาคุณภาพ ePCR

Continuous Improvement Framework

วงจรขับเคลื่อนคุณภาพ ePCR

1. ปัญหา

ยา/หัตถการ (94.5%)

2. มาตรการ

Chart Audit ทุกสัปดาห์

3. เป้าหมาย

ความสำเร็จ 100%

1. ทีมตรวจสอบเวชระเบียน (Chart Audit Team):

ตรวจสอบ ePCR รายสัปดาห์โดยพยาบาล ER หัวหน้าชุดปฏิบัติการ และทีม IT

2. ระบบป้อนกลับรายบุคคล (Individual Feedback):

สรุปข้อผิดพลาดและส่ง Feedback ทันทีเพื่อเสริมทักษะการบันทึกยาและหัตถการ

CQI Driven Data Quality

Active QA

ระบบควบคุมเอกสาร Master List 36 รายการ & PDPA Governance

เกณฑ์ 5.1 & 5.2 (100% Control)

บัญชีควบคุมเอกสารระบบ EMS (36 รายการ)

หมวด SOP/CPG/Form

รหัสเอกสาร	ชื่อเอกสารมาตรฐาน	Rev.	ประกาศใช้	ทบทวน	ผู้รับผิดชอบ
SOP-EMS-01	ขั้นตอนการรับแจ้งเหตุและสั่งการ	2.0	ต.ค. 68	ต.ค. 69	หัวหน้า EMS
CPG-EMS-01	แนวทางดูแล STEMI & Stroke Fast Track	2.1	ต.ค. 68	ต.ค. 69	Medical Director
CHK-VEH-01	Checklist ความพร้อมรถพยาบาลและอุปกรณ์	3.0	ต.ค. 68	ต.ค. 69	Safety Officer
FRM-RUN-01	Run Report Form (ePCR / NDEMS)	3.0	ต.ค. 68	ต.ค. 70	หัวหน้า EMS

Backup & DR System (5.1.1)

- Backup ประจำวันบน Cloud และ Ext-HDD
- DR Test: ฝึกซ้อมสำเร็จใน 2 ชม.

ระบบรายงาน & วิเคราะห์ (5.2.1)

- รายงานสรุปเสนอ คกก.บริหาร รพ. ทุกเดือน
- นำข้อมูลปรับปรุง CPG ต่อเนื่อง



PDPA + Data Security (ข้อ 5.1.3)

คุ้มครองข้อมูลตาม พ.ร.บ. PDPA พ.ศ. 2562

สิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล (Role-based Access)

Medical Director	Full Admin
พยาบาลวิชาชีพ (ENP)	Read + Edit + Export
ผู้ปฏิบัติการ (EMT-ALS)	เฉพาะ Case ตนเอง

มาตรการรักษาความปลอดภัยดิจิทัล

เปลี่ยน Password ทุก 90 วัน	Enforced
Login ผิด >5 ครั้ง ล็อกระบบ	Active
Audit Log บันทึกประวัติ 100%	Tracked

อบรมบุคลากร PDPA แล้ว 45 คน

0 ข้อร้องเรียน

องค์ประกอบที่ 6

การบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resources Management)

การสรรหา กำกับดูแลใบประกอบวิชาชีพ 100% การฝึกอบรมทักษะช่วยชีวิตขั้นสูง และการ
ดูแลสุขภาพของทีมกู้ชีพ 45 นาย

✓ 2 เกณฑ์คุณภาพ ☰ 4 ข้อกำหนด ★ 4 Core Criteria

📄 แหล่งอ้างอิง: เกณฑ์ TEMSA องค์ประกอบที่ 6: การบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resources Management Standards)

TEMSA Level 1 - ALS 01-2-905

องค์ประกอบที่ 6 (ผังวงจรบริหารทรัพยากรบุคคล)

ผังบริหารทรัพยากรบุคคล & การกำกับใบอนุญาต 100%

HR Lifecycle Matrix (45 คน)

01

100% Valid

ใบอนุญาตวิชาชีพ

- ENP พยาบาล: 39 คน (100%)
- EMR กู้ชีพ: 1 คน (100%)
- พนักงานขับรถ: 5 คน (100%)
- ต่ออายุล่วงหน้า 60 วัน

ไม่มีใบอนุญาตขาดอายุ 0%

02

Continuous

การฝึกอบรมขั้นสูง

- ACLS / PHTLS: ครบ 100%
- TTX ซ้อมแผน MCI ประจำปี
- EVOC ขับขี่ปลอดภัย 5 นาย
- ชั่วโมงอบรมเฉลี่ย >20 ชม./ปี

พัฒนาสมรรถนะตรงสายงาน

03

100% Insured

สุขภาพ & คัมครอง

- วัคซีน Hep B, Flu: 100%
- ตรวจสอบสุขภาพประจำปี: 100%
- ประกันอุบัติเหตุ: 2 ล้าน/คน
- ประเมินความเครียด & Burnout

ดูแลสุขภาพกาย-ใจรอบด้าน

04

Annual

ประเมินสมรรถนะ

- OSCE ประเมินทักษะทางคลินิก
- Mock Code Simulation CPR
- ประเมินโดย Medical Director
- ผลประเมินผ่านเกณฑ์ 100%

อ้างมาตรฐานวิชาชีพสม่ำเสมอ



ความพร้อมด้านกำลังคน EMS รพ.เจาะไอร้อง: มีบุคลากร 45 นาย ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน สพด. ครบ 100% พร้อมออกปฏิบัติการตลอด 24 ชั่วโมง

100% Certified Team

แหล่งอ้างอิง: ทะเบียนผู้ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ร.บ.การแพทย์ฉุกเฉิน 2551 & แผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล (IDP)

TEMSA Level 1 · ALS 01-2-905

< ย้อนกลับ

ถัดไป >

เลือกสไลด์:

28. อ.6 HR & ระบบใบอนุญาต



การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strengths) & แผนพัฒนาสู่ขั้นที่ 2

Roadmap Level 2 (2568 - 2571)



จุดแข็งความพร้อมรับรอง TEMSA ขั้นที่ 1

Ready



ภาวะผู้นำ & ระบบแพทย์อำนวยการ 24 ชม.:

มี Medical Director ให้คำปรึกษาตลอด 24 ชม. และขับเคลื่อน FAST CIR Culture



Zero Accident & ความพร้อมสูง:

อุบัติเหตุรถกู้ชีพเป็นศูนย์ 0 ครั้ง และ Response Time เฉลี่ยลดลงต่อเนื่อง (7.5 นาที)



เอกสาร Master List & ePCR 97.1%:

มี Master List 36 รายการ และบันทึก ePCR ในระบบ NDEMS สมบูรณ์สูง



พร้อมอ้างอิงมาตรฐาน TEMSA ขั้นที่ 1

High Standard



ประเด็นพัฒนาเร่งด่วน (ACTION PLAN 2569 - 2570)

In Progress



Stroke Fast Track Door-to-Refer:

พัฒนาระบบประสานญาติเพื่อเพิ่มอัตราส่งต่อทันเวลาให้บรรลุเป้าหมาย $\geq 80\%$



Community CPR & ROSC Rate Enhancement:

ขยายการอบรม High-Quality CPR & AED แก่ อสม./ชุมชน 44 หมู่บ้าน



Digital Near-Miss & EDC Smart App:

ยกระดับรายงานความเสี่ยงดิจิทัล และใช้แอปพลิเคชันคำนวณอายุครรภ์หน้างาน



พัฒนาต่อเนื่องสู่ TEMSA ขั้นที่ 2

Action Target



หมุดหมายสำคัญ (Milestone FY 2571):

ยื่นขอรับการประเมิน TEMSA ขั้นที่ 2 เพิ่ม Response Time ≤ 8 นาที ให้ได้ $\geq 90\%$ และระบบ ePCR Sync 100%

ดูแผนผัง 7 Steps →

TEMSA ACCREDITATION ROADMAP

TEMSA

แผนผังขั้นตอนการประเมินคุณภาพ TEMSA และสถานะปัจจุบัน

สถานะปัจจุบัน (CURRENT STATUS)
ขั้นตอนที่ 3: พร้อมรับการเยี่ยมสำรวจ ขั้นที่ 1

📍

เส้นทางขั้นตอนการรับรองมาตรฐาน TEMSA (คลิกที่การ์ดเพื่อเปลี่ยนสถานะ)

● ดำเนินการแล้ว

⚙️ ปัจจุบัน

● ขึ้นอนาคต

1

✓ สำเร็จ

เตรียมความพร้อม & Self-Audit

แต่งตั้ง คกก. คุณภาพ, ทำ Gap Analysis 6 องค์ประกอบ และทบทวน SOP 5 ระยะ

✓ ดำเนินการเสร็จสิ้น

2

✓ สำเร็จ

จัดเตรียมแฟ้มหลักฐาน

รวบรวมหลักฐานเชิงประจักษ์ครบถ้วน ~ 217 แฟ้ม และจัดทำระบบ Risk Profile

✓ ดำเนินการเสร็จสิ้น

3

🔧 อยู่ขั้นตอนนี้

ปัจจุบัน

ยื่น SAR & รับการประเมิน

ยื่น SAR Online สพด. (31 ก.ค. 69) และนำเสนอต่อคณะผู้ประเมินคุณภาพ (วันนี้)

พร้อมรับการตรวจ ➡

4

ขั้นถัดไป

ประกาศรับรองขั้นที่ 1

รับใบรับรอง TEMSA ขั้นที่ 1, ขึ้นทะเบียนระบบ NIEMS และรักษาสุขภาพคุณภาพ 4 ปี

★ ระยะเวลาเยี่ยมสำรวจ

5

เป้าหมายสูงสุด

ยกระดับสู่ TEMSA ขั้นที่ 2

พัฒนา EDC Smart App, ePCR 100%, Response Time < 8 นาที ≥ 90%

🎯 เป้าหมายปี 2571 🎯

✓ รายละเอียดการดำเนินงาน ณ ขั้นตอนปัจจุบัน

ขั้นที่ 3: รับการประเมิน

📁 ความพร้อมสารบัญหลักฐาน

จัดเตรียมเอกสาร SAR และหลักฐานครบ 6 องค์ประกอบ รวมทั้งสิ้น 217 แฟ้ม ยื่นผ่านระบบ TEMSA Online สพด.

👥 ความพร้อมทีมปฏิบัติการ

อัตรากำลัง ENP, EMT-ALS และ พขร. ช้อมแผนความปลอดภัย Scene Safety และอบรม Defensive Driving ครบถ้วน

🛡️ การประเมินตนเอง (3P Audit)

ประเมิน Purpose, Process, Performance พบอยู่ในระดับ "ครบเป็นส่วนใหญ่" พร้อมแก้ Gap Analysis ต่อเนื่อง

📈 ผลลัพธ์การดูแลผู้ป่วย (CPG)

STEMI Door-to-Needle 100%, Stroke Fast Track & Severe TBI Refer < 30 นาทีอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

📈 ทิศทางการพัฒนาต่อเนื่อง มุ่งสู่ขั้นที่ 2

Target 2571

p1

Operational Excellence:

เพิ่ม Response Time < 8 นาที ให้ได้ ≥ 90% และซ่อม MCI Functional

p2

Clinical & Innovation:

ใช้แอป EDC Smart App จำนวน GA และฝึก High-Quality CPR รุ่นมอนิเตอร์

p3

Safety & Digital:

รายงาน Near-Miss ผ่านแอปดิจิทัล และ ePCR Sync 100% กับระบบ NDEMS

🎯 เป้าหมายสำคัญ: ผ่านการรับรอง TEMSA ขั้นที่ 1 → ยื่นขอขั้นที่ 2 ในปีงบประมาณ 2571

📄

แหล่งอ้างอิง: แผนผังเส้นทางการรับรองมาตรฐาน TEMSA ขั้นที่ 1 สู่ขั้นที่ 2 (Accreditation Pathway 2568–2571)

TEMSA Level 1 · ALS 01-2-905

ย้อนกลับ

ถัดไป

เลือกสไลด์: 30. แผนผังขั้นตอนการประเมิน TEMSA & สถานะปัจจุบัน

เอกสารอ้างอิงและเกณฑ์มาตรฐาน (References)

Format: Vancouver / NLM Medical Citation Style

หมวดที่ 1: กฎหมายและประกาศกระทรวงสาธารณสุข (Statutory Regulations)

- [1] ราชกิจจานุเบกษา. พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551. เล่ม 125 ตอนที่ 44 ก, หน้า 1–22 (6 มีนาคม 2551).
- [2] ราชกิจจานุเบกษา. พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA). เล่ม 136 ตอนที่ 69 ก, หน้า 52–95 (27 พฤษภาคม 2562).
- [3] คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน. ประกาศ กพฉ. เรื่อง มาตรฐาน หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยปฏิบัติการแพทย์ พ.ศ. 2562. นนทบุรี: สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ; 2562.

หมวดที่ 2: เกณฑ์มาตรฐานการรับรองคุณภาพ TEMSA (Accreditation Criteria)

- [4] สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.). เกณฑ์มาตรฐานการประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (TEMSA) ชั้นที่ 1 (6 องค์ประกอบ). นนทบุรี: สพฉ.; 2562.
- [5] สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.). คู่มือแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR Guideline). นนทบุรี: สำนักรับรองคุณภาพฯ สพฉ.; 2568.

หมวดที่ 3: ระเบียบปฏิบัติการและแผนเผชิญเหตุ รพ.เจาะไอร้อง (SOPs & MCI Plans)

- [6] โรงพยาบาลเจาะไอร้อง. คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐานระบบการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูง (SOP 5 Phases, MAN-SOP-01 ถึง MAN-SOP-05). นราธิวาส: กลุ่มงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน; 2568.
- [7] โรงพยาบาลเจาะไอร้อง. แผนเผชิญเหตุสาธารณภัยและอุบัติภัยหมู่ (MCI Plan & Incident Command System). นราธิวาส: คณะกรรมการบริหารจัดการภาวะฉุกเฉิน; 2568.
- [8] เขตสุขภาพที่ 12 กระทรวงสาธารณสุข. คู่มือแนวปฏิบัติระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินทางอากาศ (Sky Doctor Region 12 Guidelines). สงขลา: สำนักงานเขตสุขภาพที่ 12; 2567.

หมวดที่ 4: แนวทางเวชปฏิบัติทางคลินิก (Clinical Practice Guidelines - CPG)

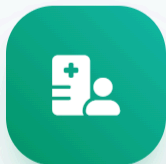
- [9] สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย. แนวทางเวชปฏิบัติการรักษาผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI Guideline). กรุงเทพฯ: สมาคมแพทย์โรคหัวใจ; 2563.
- [10] สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์. แนวทางการรักษาโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันเฉียบพลันสำหรับแพทย์ (CPG Ischemic Stroke). กรุงเทพฯ: สถาบันประสาทวิทยา; 2562.
- [11] American Heart Association. 2020 AHA Guidelines for CPR and ECC. *Circulation*. 2020;142(16_suppl_2):S366–S468.
- [12] Evans L, Rhodes A, et al. Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines for Sepsis 2021. *Crit Care Med*. 2021;49(11):e1063–e1143.
- [13] NAEMT. Prehospital Trauma Life Support (PHTLS). 9th ed. Burlington: Jones & Bartlett Learning; 2019.
- [14] Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. *Global Strategy for Diagnosis and Management of COPD (2024 Report)*. Fontana: GOLD; 2024.

หมวดที่ 5: ระบบสารสนเทศและทะเบียนหลักฐานเชิงประจักษ์ (Databases & Catalog)

- [15] สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.). ระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉิน (Information Technology for Emergency Medical System: ITEMS) และ National Digital EMS Database (NDEMS); 2568.
- [16] โรงพยาบาลเจาะไอร้อง. ทะเบียนควบคุมเอกสารระบบคุณภาพ (Master Document List 36 ฉบับ) และแฟ้มหลักฐานเชิงประจักษ์ TEMSA (Master Evidence Catalog 217 แฟ้ม). นราธิวาส: คณะกรรมการคุณภาพ EMS; 2568.

หมายเหตุการอ้างอิง: เอกสารและแนวทางเวชปฏิบัติดังกล่าวข้างต้นได้รับการจัดเก็บเป็นแฟ้มหลักฐานเชิงประจักษ์ (Hardcopy & Cloud Evidence) ประจำหน่วยปฏิบัติการแพทย์ ALS โรงพยาบาลเจาะไอร้อง

ISO 690 / Vancouver Aligned



ขอบคุณคณะผู้ประเมินคุณภาพทุกท่าน

หน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูง (ALS) โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูธร จังหวัดนนทบุรี

พร้อมรับการเยี่ยมสำรวจ และมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินอย่างต่อเนื่อง



แพทย์อำนวยการ: นายแพทย์อิลมีย์ สะแลแม (โทรปรึกษา 24 ชม.)



หัวหน้างาน EMS: นางนันทวดี จอนเจิม (หัวหน้างานการพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉิน)



Email: ems@choaironghospital.go.th



Q & A (ช่วงแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ)



กลับสู่หน้าแรก



ดูสารบัญ